

Uzależnienie *od jedzenia*?

Koncept kontrowersyjny — nie ma w ICD-11 ani DSM-5. Ale BED (kompulsywne objadanie) jest formalną diagnozą. Ultra-przetworzona żywność aktywuje układ nagrody jak narkotyki (Schulte 2015).

CZAS: 12 min **Diagnostyka + protokół** **ŹRÓDŁO:** Gearhardt (2016); Schulte (2015)

JAK UŻYWAĆ

1 · Poznasz *różnicę* między BED (formalną diagnozą DSM-5) a „uzależnieniem od jedzenia” (kontrowersyjnym konceptem klinicznym) — i kiedy każde z tych podejść jest użyteczne (sekcja 01). **2** · Zrozumiesz, dlaczego **ultra-przetworzona żywność** jest inna niż naturalna (sekcja 02). **3** · Wykonasz skrócony skrining wg YFAS 2.0 (sekcja 03). **4** · Poznasz protokół CBT-E, kluczowe zalecenia (i ostrzeżenie przed dietami restrykcyjnymi) (sekcja 04).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Pojęcie *uzależnienia od jedzenia* (ang. *food addiction*) jest klinicznie **kontrowersyjne**. Nie jest formalną diagnozą w ICD-11 ani DSM-5, ale ma rosnące poparcie naukowe. Gearhardt i wsp. (2009, 2016) opracowali *skalę uzależnienia od jedzenia Yale* (ang. *Yale Food Addiction Scale, YFAS 2.0*) — 35 pytań opartych na kryteriach uzależnień substancyjnych DSM-5. Rozpowszechnienie wg YFAS: 5–10% populacji ogólnej, 15–25% osób z otyłością, **30–50% osób z BED** (zaburzenie z napadami objadania się). Schulte i wsp. (2015) wykazali, że ultra-przetworzona żywność (wysokocukrowa, wysokotłuszczowa, słona) aktywuje jądro półleżące **silniej** niż żywność naturalna — analogicznie jak narkotyki. Badanie Connecticut College (2013): szczury „uzależnione” od Oreo miały *identyczną* aktywację jądra półleżącego jak szczury na kokainie. **Sceptycy** (Ziauddeen 2012, 2013) ostrzegają przed patologizowaniem normalnego zachowania, stygmatyzacją osób z otyłością i ignorowaniem regulacji emocji jako mechanizmu. Stanowisko pragmatyczne: *BED jest potwierdzoną kategorią diagnostyczną*, food addiction to *uzupełniający koncept* przydatny dla ciężkich wzorców z eskalacją na ultra-przetworzoną żywność. **Ostrzeżenie:** diety restrykcyjne *pogarszają* stan — restrykcja → głód → utrata kontroli → napad → poczucie porażki → restrykcja = cykl (Fairburn 2008, CBT-E).

01 BED vs food addiction — co znaczy co

BED — ZABURZENIE Z NAPADAMI OBJADANIA SIĘ
DSM-5, *formalna diagnoza*

Epizody kompulsywnego objadania **≥1 raz/tydzień** przez 3 miesiące, z poczuciem utraty kontroli, bez kompensacji (jak w bulimii). Leczenie: CBT-E (Fairburn, *d* = 0,60–0,80), MI, lisdeksamfetamina (zatwierdzona przez FDA dla BED).

FOOD ADDICTION — KONCEPT UZUPEŁNIAJĄCY
YFAS 2.0, *nieformalna*

Wzorec spełniający kryteria uzależnienia (tolerancja, odstawienie, utrata kontroli) — typowo wobec *ultra-przetworzonej* żywności. Przydatny klinicznie dla ciężkich przypadków z eskalacją. **50% osób z BED** spełnia też kryteria YFAS.

02 Dlaczego ultra-przetworzona żywność jest inna

Schulte i wsp. (2015) pokazali, że nie wszystkie pokarmy *tak samo* aktywują układ nagrody. Jabłko i czekolada — to **dwa różne mechanizmy**.

NATURALNA ŻYWNOŚĆ

Jabłko, kasza, mięso, warzywa. Wolne uwalnianie energii, błonnik spowalnia, sygnał sytości jasny. Aktywacja układu nagrody *łagodna i krótka*. Mózg „wie”, że je.

ULTRA-PRZETWORZONA ŻYWNOŚĆ

Chipsy, lody, czekolada przemysłowa, słodzone napoje. **Cukier + tłuszcz + sól** w proporcjach niewystępujących w naturze. *Zaprojektowana*, by maksymalizować dopaminę. Sygnał sytości słaby.

AKTYWACJA JĄDRA PÓŁLEŻĄCEGO

Schulte 2015: ultra-przetworzona żywność aktywuje NAcc *silniej* niż naturalna — analogicznie do narkotyków. Im wyższy *indeks glikemiczny* i im większa gęstość kaloryczna, tym silniejsza reakcja.

ESKALACJA

Po regularnym jedzeniu ultra-przetworzonej żywności mózg *obniża* reaktywność dopaminową — potrzeba **coraz więcej** dla tego samego efektu. To *tolerancja*, jedno z kryteriów uzależnień.

03 Skryning YFAS 2.0 — orientacja

Skala uzależnienia od jedzenia Yale (Gearhardt 2016, 35 pytań w pełnej wersji) — poniżej skrócona orientacja. **≥2 zaznaczenia + cierpienie** kliniczne = warto skonsultować z dietetykiem klinicznym lub psychoterapeutą.

- ☐ **Tolerancja** — z czasem potrzebuję jeść więcej tej samej rzeczy, by osiągnąć ten sam efekt.
- ☐ **Odstawienie** — gdy nie jem tej żywności, czuję objawy: drażliwość, ból głowy, niepokój.
- ☐ **Utrata kontroli** — jem więcej, niż planowałem/-am. „Tylko jeden plasterek” — kończy się na całej paczce.
- ☐ **Bezskuteczne próby** — kilkakrotnie próbowałem/-am zmniejszyć spożycie ultra-przetworzonej żywności i nie udało się.
- ☐ **Czas pochłonięty** — myślenie o jedzeniu, planowanie, kupowanie i przygotowywanie zajmuje mi nieproporcjonalnie dużo czasu.
- ☐ **Rezygnacja z aktywności** — zrezygnowałem/-am z aktywności społecznych, sportu, hobby z powodu jedzenia.
- ☐ **Kontynuacja mimo szkód** — kontynuuję ten sam wzorec mimo problemów zdrowotnych (cukrzyca, otyłość, miażdżyca).
- ☐ **Cierpienie kliniczne** — wzorec powoduje znaczne cierpienie albo upośledza funkcjonowanie.

04 CBT-E + ostrzeżenie przed dietą restrykcyjną

CO DZIAŁA — CBT-E (FAIRBURN 2008)

Regularność posiłków (3 główne + 2 przekąski w stałych godzinach). Identyfikacja wyzwalaczy emocjonalnych. Restrukturyzacja przekonań („zasłużyłem/-am — należy mi się”). Praca z obrazem ciała. Dla BED: $d = 0,60-0,80$.

CZEGO UNIKAĆ — DIETY RESTRYKCYJNE

„Od poniedziałku nic słodkiego” / „tylko 1200 kcal” / „zero węglowodanów”. Restrykcja → narastający głód → utrata kontroli → napad → poczucie porażki → nowa restrykcja = cykl. Im surowsza dieta, tym silniejszy napad po niej.

Pytanie kluczowe (do regulacji emocji): „*Jakie* uczucie tłumię, gdy sięgam po jedzenie ultra-przetworzone **nie z głodu?**” Stres? Samotność? Nuda? Złość? Pustka po pracy? Zrozumienie funkcji jest **fundamentem** — bez tego sama zmiana diety nie wystarczy.

Klucz: debata o „uzależnieniu od jedzenia” jest *otwarta*. Co **jest** jednoznaczne: (1) BED to formalna diagnoza DSM-5, leczona skutecznie CBT-E (Fairburn 2008, $d = 0,60-0,80$); (2) ultra-przetworzona żywność jest neurobiologicznie inna niż naturalna (Schulte 2015); (3) *diety restrykcyjne pogarszają stan* u osób z utratą kontroli nad jedzeniem. Najczęstsza pomyłka kliniczna: zalecanie restrykcyjnej diety osobie z BED — gwarancja nawrotu. Najczęstsza pomyłka pacjenta: szukanie „dobrej diety” zamiast pracy z regulacją emocji. Skuteczne podejście to *regularność posiłków* (3 + 2), *intuicyjne jedzenie*, *praca z emocjami* jako trigger oraz konsultacja z dietetykiem specjalizującym się w zaburzeniach odżywiania.